

SURAT EDARAN
NOMOR: 308/RSPHS/I-SE/DIR/VI/2026

TENTANG
KEBIJAKAN LAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBGYN)
BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN

Menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Jawa Timur Nomor 03/TKMKB/Prov.Jatim/0625, serta melengkapi Surat Edaran nomor 189/RSPHS/I-SE/DIR/III/2026 Tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Sectio Caesaria dan mencabut Surat Edaran tentang Tindakan Kuretase Tanpa Penyulit Nomor: 978/RSPHS/I-SE/DIR/XI/2025, maka ditetapkan ketentuan terbaru terkait layanan Obgyn di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut:

A. Ketentuan Tindakan Sectio Caesarea (SC)

1. Kepatuhan Terhadap Indikasi Medis Tindakan SC

Prosedur SC harus dilakukan sesuai indikasi medis yang benar, berdasarkan pedoman klinis yang berlaku. Beberapa evaluasi khusus terkait indikasi meliputi:

- a) **Ketuban Pecah Dini (KPD) & BSC 1x:** Kasus KPD harus menyertakan bukti upaya persalinan pervaginam atau induksi, dan BSC 1x tidak dapat langsung dilakukan SC tanpa adanya indikasi lain yang mendukung dan harus tertulis pada lembar observasi ponek mulai dari vital sign sampai VT untuk membuktikan adanya Upaya persalinan pervaginam dahulu, serta dilengkapi dengan ketentuan :
 - KPD adalah kondisi patologis di mana selaput ketuban pecah sebelum persalinan atau sebelum adanya tanda *inpartu*.
 - Diagnosis wajib dibuktikan dengan tes lakmus.
 - Kriteria diagnosis dan tata laksana KPD harus tercantum secara jelas dan detail di dalam Rekam Medis pasien.
- b) **Kriteria Induksi Gagal :** tidak mencantumkan indikasi gagal maternal maupun fetal, belum mencapai 2 kolf sudah di katakana gagal, BSC 1x tanpa ada indikasi lainnya
- c) **Oligohidramnion:** Wajib menyertakan keterangan AFI pada hasil foto USG, di mana AFI <4 merupakan indikasi absolut SC, jika AFI <8 harus ada penyebab lain yang mendukung
- d) **Lilitan Tali Pusat :** pada kasus persalinan dengan lilitan tali pusat, harus dilakukan upaya partus percobaan dan melampirkan lembar observasi ponek sebagai Upaya persalinan pervaginam
- e) **Prolonged kala 1 fase laten :** pada prolonged kala 1 fase laten (pembukaan <3) seharusnya ditunggu atau dipulangkan dahulu sebagai pasien rawat jalan.
- f) **Prolonged kala 1 fase aktif :** harus disertai upaya induksi akselerasi dan didapatkan keterangan kelainan presentasi (letak puncak) pada lembar patograph
- g) **CPD :** Pada diagnosa CPD(disproporsi) harus ada keterangan ukuran panggul dalam (baik saat ANC/MRS) alat ukur panggul, tinggi badan dan berat badan tersedia di PONEK
- h) **Miopia Tinggi:** Kasus miopia (misalnya spheris -7) wajib dikonsultasikan dan disertai hasil pemeriksaan dari Dokter Spesialis Mata yang menerangkan adanya kelainan atau degenerasi retina.
- i) **Primi Tua:** Kondisi primi tua bukan merupakan indikasi absolut untuk prosedur SC.
- j) **Preeklamsia Berat (PEB):** Pastikan diagnosis PEB sudah tegak dengan adanya proteinuria dan tensi tinggi
- k) **Bayi Besar :** harus disertai dengan data dukung berupa (TFU >40 cm, BB bayi saat lahir >3800gr, TBJ dari USG beserta hasil bacaan)
- l) **Fetal Distress:** Diagnosis *fetal distress* dan hasil *Non-Stress Test* (NST) normal, harus disertai dengan bukti tatalaksana awal seperti rehidrasi, pemberian oksigen, dan posisi miring kiri yang tertulis pada lembar observasi ponek, resume medis, dan CPPT.



2. Indikasi Maternal :

- a) **Impending Eklamsia/Eklamsia** : pemeriksaan penunjang lab protein urin, ureum kreatinin, sgot sgpt klinis HT/odema tungkai/penurunan kesadaran, nyeri ulu hati, pandangan kabur, mual, muntah
- b) **Solusio plasenta** : lampirkan hasil USG beserta bacaan CTG/NST
- c) **Plasenta previa** : lampirkan hasil USG beserta bacaan
- d) **Ruptur uteri** : (iminens atau komplate) lampirkan hasil USG beserta bacaan
- e) **Prolaps tali pusat** : Palpasi Per Vaginam (VT) dituliskan resume medis pada pemeriksaan fisik / CTG / hasil USG beserta bacaan
- f) **Secondary Arrest** : lampirkan lembar Partograf
- g) Riwayat Sectio Caesaria sebelumnya (terutama bila > 2x atau insisi sebelumnya corporil) disertai penyakit lain spt KPP, PEB, Obesitas dll : lampirkan lembar observasi obstetri untuk riwayat SC pada pengkajian awal medis kandungan dan kebidanan
- h) **Penyakit jantung berat** : melampirkan hasil EKG/echocardiografi beserta bacaanya
- i) **Penyakit menular genitalia** (contoh HIV dengan viral load tinggi atau Sifilis aktif) : pemeriksanan darah lengkap, triple eliminasi (HIV, siphilis, HbsAg)
- j) **Gagal induksi** : lampirkan lembar Partograf
- k) **Obesitas ekstrem** : lampirkan data berat badan pasien pada lembar pengkajian awal medis kandungan dan kebidanan serta pada resume medis

3. Indikasi janin

- a) **Distress janin akut** : melampirkan hasil CTG/NST beserta bacaan
- b) **Janin IUGD** (<10th centile) dengan aliran dopples abnormal : lampirkan hasil USG Dopler beserta bacaan
- c) **Malpresentasi letak (misal letak sungsang, lintang)** : lampirkan hasil USG beserta bacaan
- d) **Kehamilan ganda dengan presentasi janin pertama bukan kepala** : lampirkan hasil USG beserta bacaan
- e) **Malformasi janin (misalnya hidrocefalus besar)** : lampirkan hasil USG beserta bacaan

4. Kelengkapan dan Konsistensi Rekam Medis

Untuk menghindari temuan administratif dan potensi gagal klaim, DPJP diwajibkan menuliskan rekam medis serta resume medis secara lengkap dan baik.

- a) **Konsistensi Dokumen**: Harus terdapat sinkronisasi pencatatan di seluruh dokumen, mulai dari lembar triase, lembar observasi, CPPT, hingga pengkajian awal dan resume medis.
- b) **Kelengkapan Data Penunjang**: Setiap penegakan diagnosis harus didukung data yang lengkap, seperti melampirkan hasil bacaan USG dan mencatatkan kondisi bayi baru lahir secara detail (berat badan bayi, jenis kelamin, dll) pada laporan operasi.
- c) **Pengisian Partograf**: Seluruh lembar partograf selama proses observasi persalinan wajib diisi secara lengkap tanpa terkecuali.
- d) **Penerimaan Rujukan** : penerimaan rujukan dari bidan praktek atau FKTP wajib dilakukan assessment kembali terkait kesesuaian indikasi dilakukan SC
- e) **Laporan Tindakan operatif memuat informasi**
 1. Operator
 2. Jenis bius yang digunakan
 3. Jenis sayatan terutama sayatan pada uterus
 4. Cara melahirkan bayi saat SC
 5. Perdarahan selama operasi
 6. Komplikasi selama operasi
 7. KB yang digunakan salam operasi bila ada (missal pemasangan IUD atau sterilisasi)



B. Ketentuan Tindakan Kuretase

1. Rawat Jalan :
Seluruh tindakan kuretase dikategorikan sebagai kasus ODC (*One Day Care*).
2. Rawat Inap :
Pasien dapat dirawat inap apabila memenuhi kriteria berikut:
 - a) Perdarahan Aktif : Kondisi yang menyebabkan gangguan hemodinamik (pre-syok, oliguri, akral dingin, dsb) yang memerlukan observasi ketat
 - b) Penyakit Penyerta : Memiliki riwayat penyakit jantung, Diabetes Melitus tidak terkontrol (GDA > 200), riwayat autoimun, kelainan hormon tiroid, atau riwayat abortus berulang.
 - c) Kasus Mola : Harus dibuktikan dengan hasil USG. Jika USG tidak memungkinkan, wajib melampirkan foto hasil kuretase mola.

C. Ketentuan Persalinan Pervaginal (Normal)

1. Kriteria Gawat Darurat: Persalinan masuk kriteria gawat darurat jika sudah masuk fase aktif sesuai *partograph* dengan dilatasi serviks > 4 cm. Kondisi ini wajib tercatat dalam rekam medis dan resume medis.
2. Kewenangan Klinis: Seluruh kasus persalinan pervaginal harus dilakukan oleh DPJP Sp.OG, mulai dari Kala 3 hingga proses penjahitan perineum.
3. Status Perawatan: Semua kasus persalinan pervaginal dikategorikan sebagai kasus ODC (*One Day Care*).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan akuntabel. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 03 Juni 2026
Direktur RS Prima Husada Sukorejo,



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep